

PASAPORTE MÉDICO DIGITAL

ID: PAC-2026-NCHO

Generado: 10/06/2026

HISTORIAL CLÍNICO LONGITUDINAL AUMENTADO POR IA

⚠ ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA (CRITICAL ALERTS)

Antecedente de Alto Riesgo Neurológico: El paciente presenta antecedentes de **colesteatoma** en el oído izquierdo intervenido quirúrgicamente. Ante cuadros de cefalea intensa acompañada de síndrome febril, descartar inmediatamente complicaciones intracraneales secundarias (ej: meningitis, absceso cerebral) antes de etiquetar como migraña común.

1. PERFIL CLÍNICO BASE (CLINICAL BASELINE)

CONDICIÓN / DIAGNÓSTICO DE FONDO	TRATAMIENTO ACTIVO / MEDICACIÓN	NOTAS / POSOLOGÍA
Talasemia (Rasgo Minor)	Lansoprazol 20mg	Uso continuo crónico (diario, en ayunas) desde hace varios años para control de ERGE.
ERGE (Enf. por Reflujo Gastroesofágico)		

2. HISTORIAL CRONOLÓGICO DE EPISODIOS (CLINICAL TIMELINE)

Junio 2026 **URGENCIAS / ALERTA**

Cefalea Aguda Intensa y Síndrome Febril

El paciente acude por cuadro de jaqueca refractaria a analgésicos comunes y febrícula. Evaluado bajo sospecha activa de complicaciones intracraneales debido a su perfil longitudinal.

📍 Hospital Reina Sofía | Dr. Torres (Urgencias)

Año 2010 (~12 años de edad) **CIRUGÍA MAYOR**

Timpanoplastia / Mastoidectomía por Colesteatoma

Intervención quirúrgica radical para la extirpación de colesteatoma en el oído izquierdo. Evolución favorable, pero con propensión documentada a alteraciones del oído medio y monitorización de bandera roja neurológica.

📍 Complejo Hospitalario - Otorrinolaringología

Control de Síndrome Esofágico

Monitorización intermitente de síntomas de ERGE. Controlado de forma estable mediante inhibidores de la bomba de protones (Lansoprazol). Sin incidencias de estenosis ni esófago de Barrett documentadas.

 Medicina Familiar

Este documento ha sido consolidado automáticamente mediante un sistema de Historial Digital Aumentado por IA a partir de transcripciones de voz e informes estructurados del paciente. Almacenamiento local seguro (Privacy by Design).